ONEMA-POP-045 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-045 — Contingência para Intercorrência Técnica

Crítica Durante Triagem

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Contingência para Intercorrência Técnica Crítica Durante Triagem. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Interrupção crítica de triagem com paciente potencialmente instável ou ordem de urgência não confirmada. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: canal de voz de contingência, contatos autorizados, lista de acionamento RT e formulário de evento. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Último sinal relatado, gravidade presumida, endereço/localização, tempo desde perda de contato e contato de responsável. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Marcar momento da perda e a última informação clínica confirmada.

2. Se havia sinal de emergência, priorizar tentativa imediata de contato telefônico, sem esperar retorno do

aplicativo.

3. Ao restabelecer contato, confirmar localização e instruir acionamento do SAMU 192, se indicado.

4. Se paciente não responder, seguir plano institucional previamente autorizado para contato do responsável e

escalonamento ao RT.

5. Não divulgar informações clínicas a terceiros não autorizados, salvo hipótese legal e necessidade de proteção à

vida.

6. Não classificar como atendimento concluído enquanto a orientação crítica não tiver desfecho documentado.

7. Documentar todas as tentativas, horários, números institucionais usados e respostas obtidas.

8. Registrar incidente, avaliar necessidade de notificação interna e revisar causa-raiz após estabilização.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Falha simultânea de canais ou ausência de confirmação em situação de risco: escalonamento imediato; não substituir serviço de emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Explicar limites de disponibilidade digital e orientar canais públicos de emergência.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

 OMS — Global Patient Safety Action Plan — https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.